



EPICRISIS – RESUMEN DE ATENCIÓN HOSPITALARIA

Servicio de Medicina Interna – Unidad de Cuidado Intermedio · Egreso: 24/09/2026

1. Identificación del paciente

Nombre	Wilson Alberto Jaimes Prada	Documento	CC 91.478.211
Edad / Sexo	45 años / Masculino (nac. 17/02/1981)	Procedencia	Girón, Santander
Ocupación	Conductor de tractomula	Régimen / EPS	Contributivo – Nueva EPS
Ingreso / Estancia	18/09/2026 · 6 días	Canal de ingreso	Urgencias (referido de primer nivel)

2. Motivo de consulta

“Me dio un ahogo de repente y un dolor en el pecho al respirar”.

3. Enfermedad actual

Disnea súbita hace aproximadamente 6 horas mientras descargaba mercancía, asociada a dolor torácico pleurítico en hemitórax izquierdo, palpitaciones y un episodio de mareo sin pérdida de conciencia. En los últimos 7 días completó el trayecto Buenaventura–Cúcuta–Bucaramanga con jornadas de conducción de más de 12 horas. Desde hace 5 días refiere dolor y aumento de volumen en la pantorrilla derecha, atribuidos a un golpe. Niega hemoptisis, fiebre, cirugía o trauma reciente.

4. Antecedentes

- Patológicos:** obesidad grado I (IMC 34); sin otras patologías conocidas; niega trombosis previa. No toma medicamentos.
- Tóxicos:** fumador de 10 cigarrillos/día por 20 años (10 paquetes/año); alcohol ocasional.
- Familiares:** madre con trombosis venosa en miembro inferior a los 55 años.
- Alergias:** no conocidas. **Quirúrgicos:** ninguno.

5. Examen físico al ingreso

TA	FC	FR	SatO ₂	T°	Peso / Talla	Glasgow
112/72 mmHg	118 lpm	26 rpm	90 % (FiO ₂ 21 %)	36,8 °C	104 kg / 1,75 m (IMC 34)	15/15

Paciente ansioso, diaforético, taquipneico. Sin ingurgitación yugular. Ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, con reforzamiento del segundo ruido pulmonar, sin soplos. Murmullo vesicular conservado bilateral, sin estertores ni frote pleural. Miembro inferior derecho con edema asimétrico (diferencia de 3,5 cm en el perímetro de la pantorrilla), dolor a la palpación de la masa gemelar y signo de Homans positivo, sin cambios de coloración. Escala de Wells para TEP: 7,5 puntos (probabilidad alta); Wells para TVP: 3 puntos.

6. Ayudas diagnósticas principales

Estudio	Resultado / hallazgos relevantes
Biomarcadores	Dímero D 4.850 ng/mL (ref. < 500) · troponina I hs 0,09 ng/mL (elevación leve) · NT-proBNP 620 pg/mL.
Gases arteriales (FiO ₂ 21 %)	pH 7,47 · PaCO ₂ 30 mmHg · PaO ₂ 61 mmHg · HCO ₃ 22 mEq/L. Alcalosis respiratoria con hipoxemia y gradiente alveolo-arterial aumentado.
Laboratorios	Leucocitos 9.800 · Hb 15,6 g/dL · plaquetas 235.000 · creatinina 1,0 mg/dL (depuración estimada 118 mL/min) · TP 12,8 s (INR 1,0) · TPT 29 s · AST/ALT normales.
ECG	Taquicardia sinusal 116 lpm, patrón S1Q3T3, inversión de la onda T en V1-V3.

Este documento es confidencial y contiene información médica protegida por la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y normativas vigentes en Colombia.

Documento: EPICRISIS-2026-006 · Historia clínica N.º HC-2026-04592
Paciente: Wilson Alberto Jaimes Prada · CC 91.478.211
Servicio: Medicina Interna – Unidad de Cuidado Intermedio · Generado: 24/09/2026
Documento sintético para pruebas de software. No corresponde a un paciente real.

Firma y Sello del Médico Tratante

Nombre: Dra. Sandra Milena Rueda Quintero
Especialidad: Medicina Interna – Neumología
Registro Médico: RM 68-04-6603 (ReTHUS)



Estudio	Resultado / hallazgos relevantes
AngioTAC de tórax	Defectos de llenado en arteria pulmonar principal izquierda con extensión a ramas lobares inferiores bilaterales: tromboembolismo pulmonar agudo bilateral. Relación VD/VI 1,1. Sin infarto pulmonar. Rx de tórax previa normal.
Doppler venoso MMII	Trombosis venosa profunda oclusiva de vena poplítea y femoral superficial derecha.
Ecocardiograma	FEVI 60 %; dilatación leve del ventrículo derecho; TAPSE 16 mm; PSAP 42 mmHg; sin trombo en cavidades. Riesgo: intermedio-alto (SPESI 1, disfunción del VD por imagen y troponina positiva).

7. Diagnóstico de ingreso

Tromboembolismo pulmonar agudo bilateral, riesgo intermedio-alto (**I26.9**) · Trombosis venosa profunda femoropoplítea derecha (**I80.1**) · Obesidad grado I (**E66.0**) · Dependencia del tabaco (**F17.2**).

8. Resumen de estancia y conducta terapéutica

Ante probabilidad clínica alta se inicia anticoagulación con enoxaparina 100 mg SC cada 12 horas antes de la confirmación imagenológica. Por riesgo intermedio-alto ingresa a unidad de cuidado intermedio con vigilancia hemodinámica durante 48 horas; no presenta hipotensión ni deterioro, por lo que no requiere trombólisis sistémica. Oxígeno por cánula nasal a 2-3 L/min durante los primeros 3 días. Al día 4, ya estable, se hace transición a apixabán oral. Se descarta neoplasia oculta con examen físico, hemograma, función hepática y radiografía de tórax normales; no se amplían estudios por existir un factor desencadenante claro (inmovilización prolongada por conducción). Sin indicación de filtro de vena cava. Educación sobre anticoagulación, riesgo de sangrado e interacciones. Se emite incapacidad por 30 días con restricción de conducción prolongada. **Condición al egreso:** Vivo, estable, SatO₂ 95 % al aire ambiente, sin disnea en reposo. Egreso a domicilio con anticoagulación oral.

9. Diagnóstico de egreso

Diagnóstico	CIE-10
TEP agudo bilateral provocado (inmovilización prolongada), riesgo intermedio-alto, estable	I26.9
Trombosis venosa profunda femoropoplítea derecha	I80.1
Obesidad grado I (E66.0) · Dependencia del tabaco (F17.2)	Ver texto

10. Plan de egreso

Medicación domiciliaria	Dosis y vía	Frecuencia / duración
Apixabán 5 mg (Eliquis) – fase inicial	2 tabletas (10 mg) VO	Cada 12 h, 3 días más (total 7)
Apixabán 5 mg (Eliquis) – mantenimiento	1 tableta (5 mg) VO	Cada 12 h desde día 8; mín. 3 meses
Acetaminofén 500 mg	1 tableta VO	Cada 8 horas si dolor
Media de compresión graduada 20-30 mmHg	Miembro inferior derecho	Durante el día
AINE (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno) y ASA	Contraindicados	No usar sin indicación médica

Recomendaciones no farmacológicas	Citas de control	Signos de alarma – acudir a Urgencias
• Caminar desde el primer día; no permanecer sentado más de 2 horas seguidas. • En viajes largos, pausas cada 2 horas para caminar; hidratación abundante. • Dejar el tabaco y bajar de peso; informar que está anticoagulado en toda atención médica.	• Medicina interna en 2 semanas y a los 3 meses (duración de la anticoagulación). • Hemograma y creatinina en 4 semanas. • Ecocardiograma y Doppler venoso de control en 3 meses.	• Ahogo súbito, dolor en el pecho o desmayo. • Sangrado que no para: nariz, encías, orina, heces negras o vómito con sangre. • Dolor de cabeza intenso y súbito; aumento del dolor o hinchazón de la pierna.

Este documento es confidencial y contiene información médica protegida por la Ley 1581 de 2012 (Habeas Data) y normativas vigentes en Colombia.

Documento: EPICRISIS-2026-006 · Historia clínica N.º HC-2026-04592
Paciente: Wilson Alberto Jaimes Prada · CC 91.478.211
Servicio: Medicina Interna – Unidad de Cuidado Intermedio · Generado: 24/09/2026
Documento sintético para pruebas de software. No corresponde a un paciente real.

Firma y Sello del Médico Tratante

Nombre: Dra. Sandra Milena Rueda Quintero
Especialidad: Medicina Interna – Neumología
Registro Médico: RM 68-04-6603 (ReTHUS)